



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : امنة عبد الحميد احمد على

المحافظة : الجيزة

الحي / المدينة : الحوامديه

العنوان : مساكن منى الامير
الحوامدية الجيزة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 27-09-2026

رقم البطاقة : 27505082402345 رقم التليفون : 01118949960

العمر(تاريخ الميلاد) : 08-05-1975 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. ----- /د. ----- /د. ----- /د. -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
جهة العلاج :
ملاحظات :
قسم :
نفقات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: امانة عبد الحميد احمد علي National ID: 27505082402345	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

MDT FORM

29/7/2025 G

<u>Name</u>	آمنہ محمد علی	<u>MRN</u>	210.0.125.125
		<u>ID</u>	52/57.8
<u>Age</u>	20	<u>Phone</u>	111 1989 97
<u>Menopausal status</u>	Post	<u>Marital status</u>	Married
<u>NRS SCORE</u>		<u>Family history</u>	-ve
<u>BMI</u>		<u>REASON OF MDT</u>	Post op
<u>CO morbidity</u>			

Clinical Data

St chrys

BX: Residual IDC GIII + 15% D

RIS high grade with comedo type
free ^{skin} margins, S.LNB → 0/2

<u>ER:</u> 0/8	<u>PR:</u> 3/8	<u>HER 2:</u> 0	<u>Ki67:</u> 75%
-------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Sonomammography:

Mets Workup:

$g \rho T_2 N M$

Willis
C. COL/N/CV
Dr. Nash

27/7/2025

Recommendations:

Recommendations:
 Received NACT 4AIC + 12 W10del.

MDT OUTCOME & PLAN

- ① Capecitabine X 6 months
- ② PORT
- ③ Tamoxifen X 5yrs.

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			

Patient Name: Amna Abdel Hameed Ahmed Ali	Date : 29/05/2025
Exam : C.T CHEST	Age : 50 Year(s)
Medical ID: 2604/2024	Pat. ID: 77497

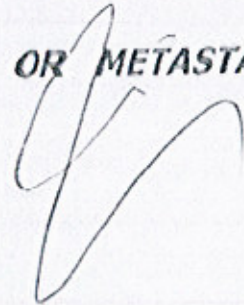
NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST: -

Findings:

- Right breast UIQ irregular mass inseparable from the pectoral muscles with internal clip measuring 2.8 X 3.8 cm.
- Clear both lung fields
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- No gross cardiac abnormality. No pericardial effusion detected.
- Normal non-enhanced appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Normal appearance of the chest wall.
- Upper abdominal cuts are unremarkable.
- Right thyroid hypodense nodule measuring 1.5 cm for sonographic assessment.

OPINION:

• ***NO EVIDENCE OF PNEUMONIA OR METASTATIC DEPOSITS.***



Dr. Mohamed Mohsen, M.D.

Name: امنه عبد الحميد احمد		
MR. : 1490		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه The patient received neoadjuvant chemotherapy consisting of 4 cycles of AC followed by 12 doses of Taxol in November 2024. She subsequently underwent a right wide local excision with sentinel lymph node biopsy in July 2025, after which adjuvant capecitabine, radiation therapy (PORT), and tamoxifen were initiated. The patient presented for cycle 3 of adjuvant Xeloda; platelet count was $70 \times 10^9/L$ requiring manual counting. The patient has completed cycle 3 of adjuvant Xeloda. The patient is a 50-year-old individual with right breast invasive ductal carcinoma, grade II, ER 0/8, PR 3/8, HER2-negative, Ki-67 75 %. She received the same neoadjuvant regimen (4 AC + 12 Taxol) in November 2024, surgery in July 2025, and then capecitabine, PORT, and tamoxifen. Radiation was completed in October 2025 after 20 fractions. She is now on cycle 4 of Xeloda, prescribed 5 days on/14 days off; platelet count is $68 \times 10^9/L$. The patient has completed cycle 4 of Xeloda. The patient continued on cycle 4 of Xeloda with a platelet count of $93 \times 10^9/L$ after consultation with Dr. Mohamed Kelany; hematology was consulted and the regimen was noted as Xeloda 3 + 2 $\times$ 5. The patient has completed cycle 4 of Xeloda. The patient remains on Xeloda and has developed thrombocytopenia, presumed drug-induced; dose reduction is requested and the drug should be held until platelet counts rise to an acceptable level, with repeat bone marrow aspiration and biopsy if needed. Laboratory evaluation shows ANC $2.79 \times 10^9/L$ and platelet count $79 \times 10^9/L$; the team deemed it acceptable to administer the prescribed Xeloda dose of 2 $\times$ 2 $\times$ 14. The patient is receiving cycle 5 of adjuvant Xeloda, dosed 2 $\times$ 2 $\times$ 14 days; platelet count is $71 \times 10^9/L$, total leukocyte count $3.9 \times 10^9/L$, neutrophils $2.11 \times 10^9/L$. The patient has completed cycle 5 of adjuvant Xeloda. Post-neoadjuvant residual disease is ypT2; the multidisciplinary team recommended capecitabine plus tamoxifen after completion of Xeloda (ER 0/8, PR 3/8). Current Xeloda dosing is 2 $\times$ 2 $\times$ 14; laboratory values are platelet $81 \times 10^9/L$, total leukocyte count $3.3 \times 10^9/L$, ANC $1.69 \times 10^9/L$. The patient is now on cycle 8 of Xeloda, prescribed 3 $\times$ 2 $\times$ 14; estrogen receptor remains 0/8, progesterone receptor 3/8, HER2 negative. The patient has completed cycle 8 of Xeloda.		
تحريرا في ,		
	التاريخ : 19-09-2026	الوقت :
	نهي سعيد علي محمد	الطبيب المعالج :
يعتمد ,		